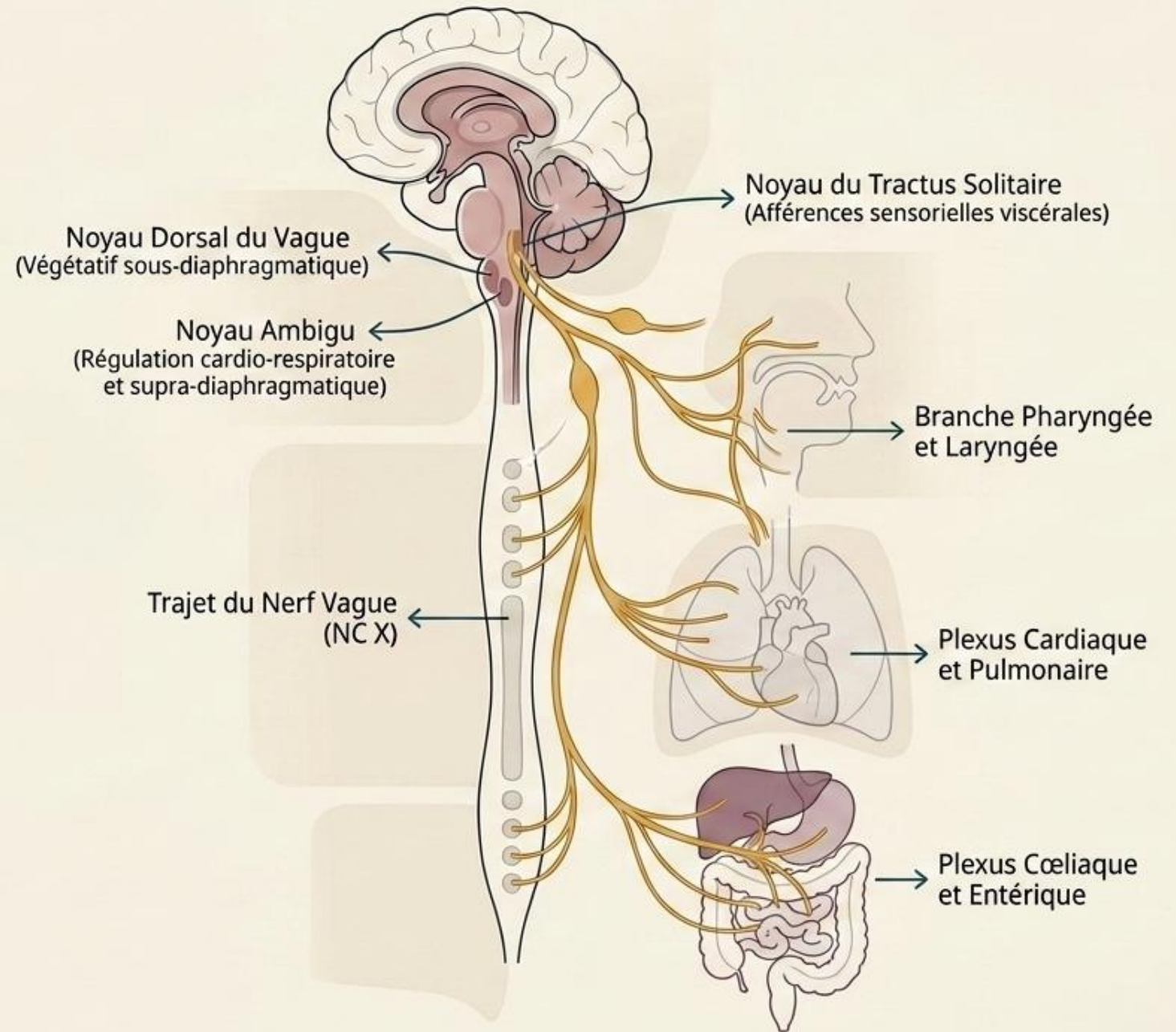


Théorie Polyvagale et ROP

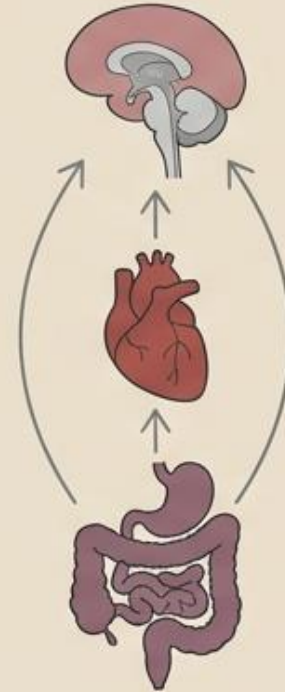


Le Syndrome Général d'Adaptation (SGA)



Historiquement, la réponse au stress était vue comme une activation prioritaire et exclusive du système sympathique.

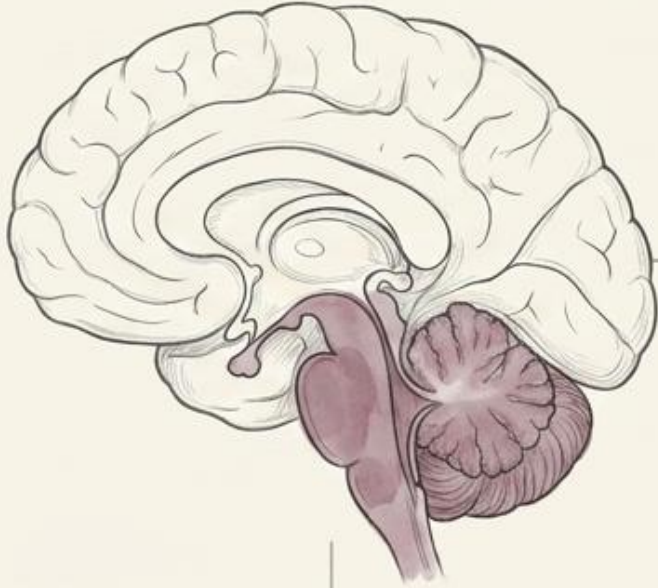
La Théorie Polyvagale (Stephen Porges)



Met en évidence le rôle différencié de deux voies vagales distinctes.

80% des afférences viscérales transmises au cerveau proviennent du nerf vague.
L'état corporel dicte l'état mental et émotionnel.

La Chronologie Évolutive du Système Autonome



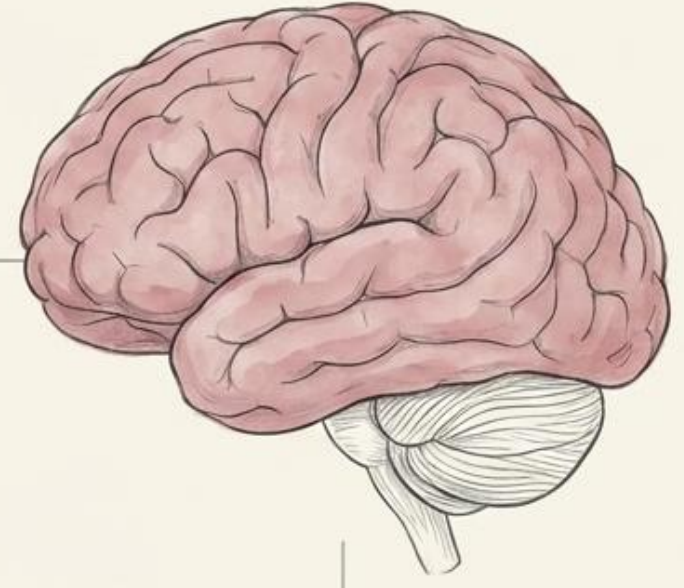
Phase 1 (Reptilien) : Branche Ancienne du Nerf Vague

Immobilisation, figement, bradycardie.
La réponse de dernier recours quand la fuite est impossible.



Phase 2 (Mammifère Ancien) : Système Sympathique

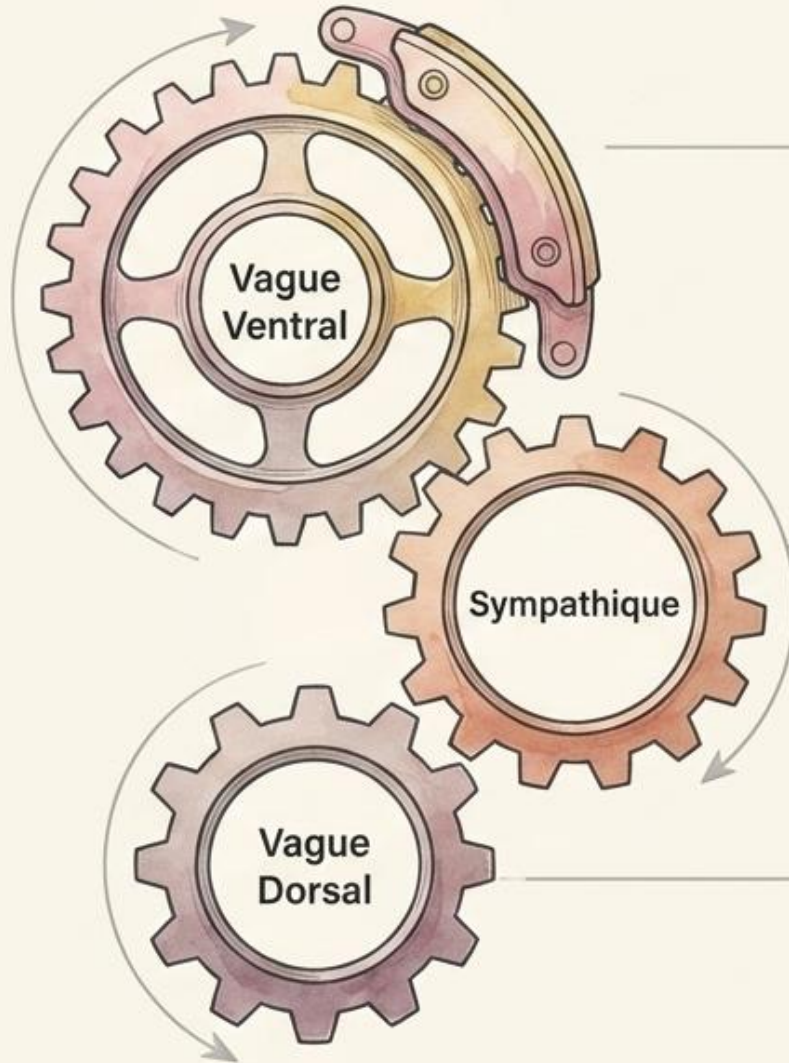
Mobilisation, fuite ou combat.
Apparu pour l'exploration et la défense active.



Phase 3 (Humain/Mammifère Supérieur) : Branche Nouvelle du Nerf Vague

Engagement social, sécurité, apaisement.
Liée au cerveau cognitif et à l'attachement affectif.

La Neuroception et le Frein Vagal



Le Contrôle Supérieur

Dans un environnement sûr, la branche ventrale maintient un frein actif sur le système sympathique.

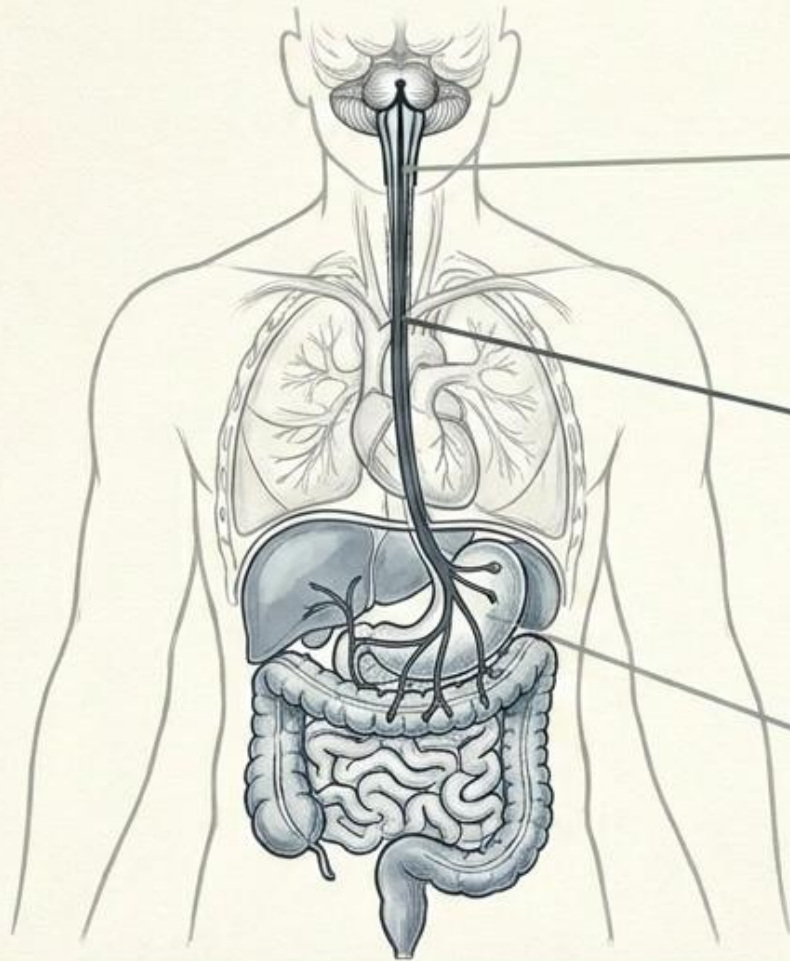
La Libération Sympathique

C'est essentiellement l'abaissement du tonus vagal ventral (face à une menace) qui libère l'activité sympathique, et non une augmentation indépendante de ce dernier.

L'Effondrement

Si le sympathique est submergé, le vague ancien (dorsal) prend le relais, provoquant figeage ou syncope (malaise vagal).

Phase 1 : Le Nerf Vague Ancien (Branche Dorsale)



Origine : Noyau dorsal de la moelle allongée (Tronc cérébral). Fibres non myélinisées (conduction lente).

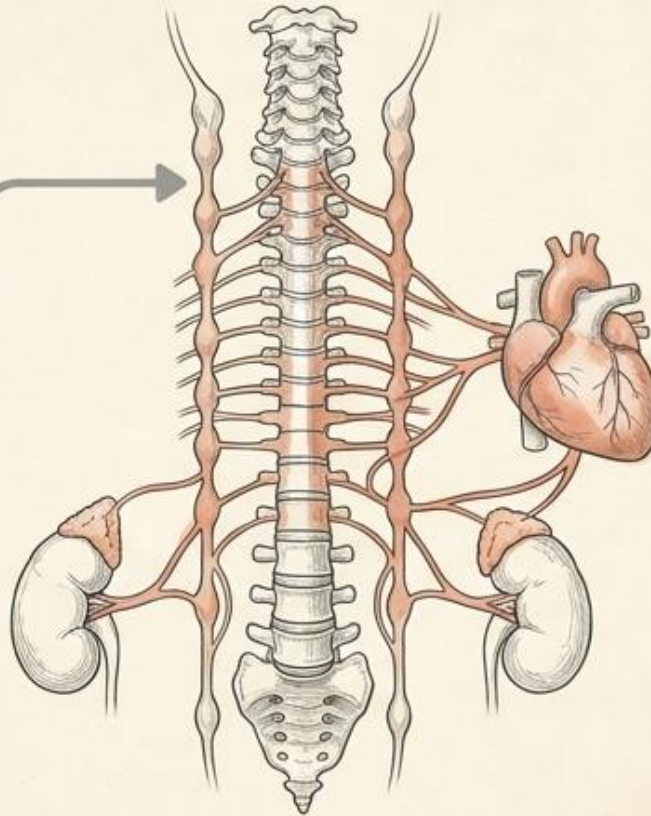
Non-myélinisé

Destinée : Viscères infra-diaphragmatiques (digestifs, génitaux, urinaires).

Mode de réponse : Se figer, s'évanouir, bradycardie.
Activé quand la fuite ou le combat sont impossibles.

Phase 2 : Le Système Sympathique

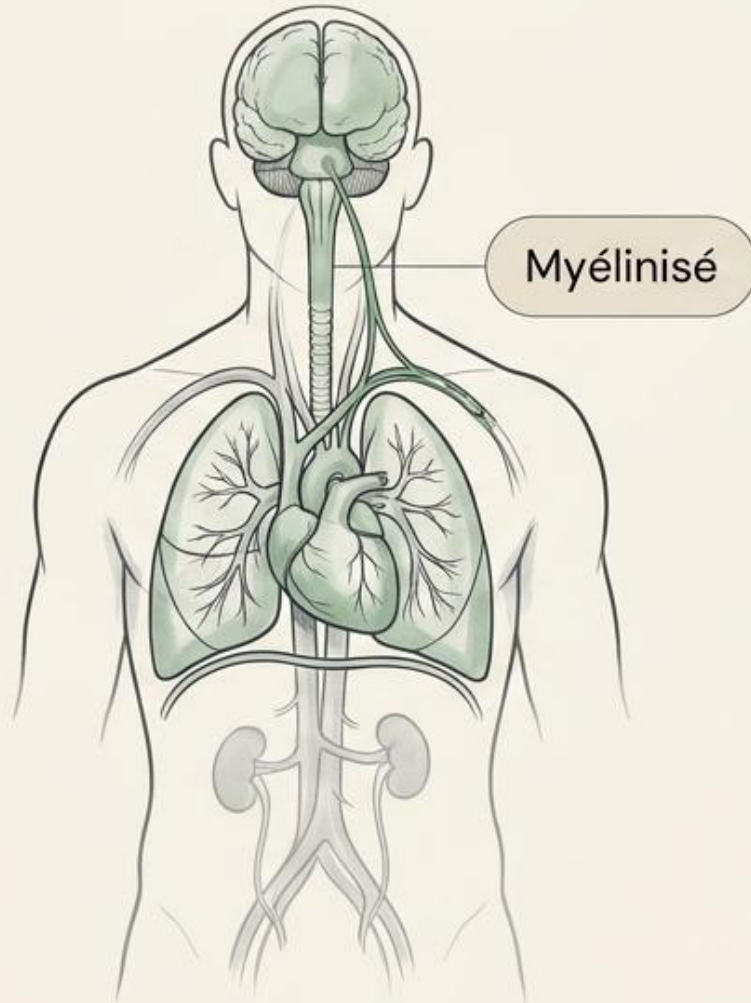
Développement
parallèle au système
limbique.
Émergence au niveau
de la moelle épinière.



Destinée :
Action musculaire,
accélération
cardiaque,
mobilisation globale.

Mode de **réponse** : Fuir ou combattre face à un
environnement hostile.

Phase 3 : Le Nerf Vague Nouveau (Branche Ventrale)



Origine : Noyau ambigu de la moelle allongée.
Fibres myélinisées (conduction rapide et modulée).
Destinée : Organes sus-diaphragmatiques (cœur, poumons).

Régule le rythme cardiaque et la Variabilité de la Fréquence Cardiaque (VRC). Une VRC élevée offre flexibilité et adaptation au stress.

Mode de réponse : Engagement social, apaisement, sentiment de sécurité.



L'Odeur : Nerf olfactif (I)

Le Contact Visuel : Nerfs optique (II)
et oculomoteurs (III, IV, VI)

Le Regard (orientation) : Nerf accessoire (XI)

L'Expression Faciale : Nerf facial (VII)

La Voix : Nerf vestibulaire-cochléaire (VIII)

Le Toucher & La Succion : Nerf trijumeau (V),
glosso-pharyngien (IX), hypoglosse (XII) - Permet
la tétée, la mastication et la vocalisation.

À la naissance, la survie dépend de ces afférences.
Dans des conditions optimales, ce complexe crânien
(Branche Ventrale) exerce un contrôle hiérarchisé sur
l'ensemble du système autonome.

Le Paradoxe Vagal

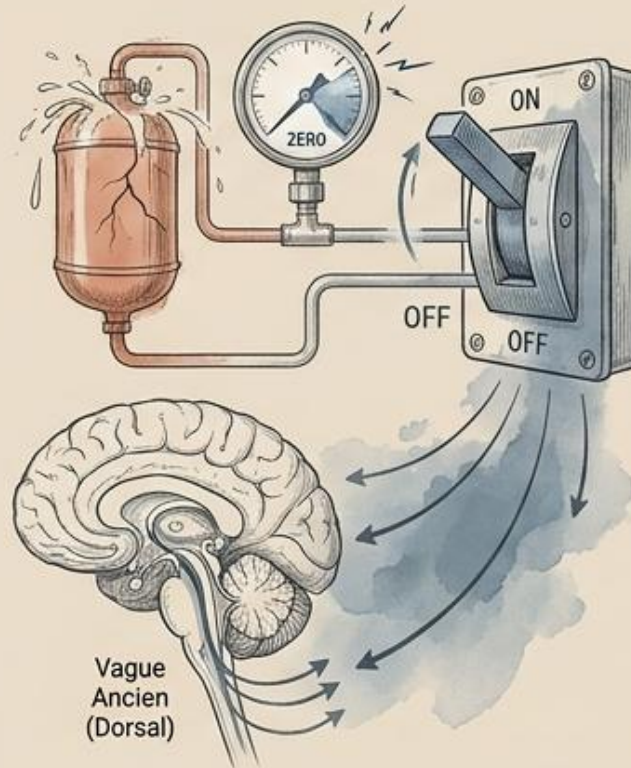


La contradiction parasympathique

Comment un système conçu pour apaiser peut-il provoquer nausées, colites, fatigue extrême ou syncope (Malaise vagal) ?

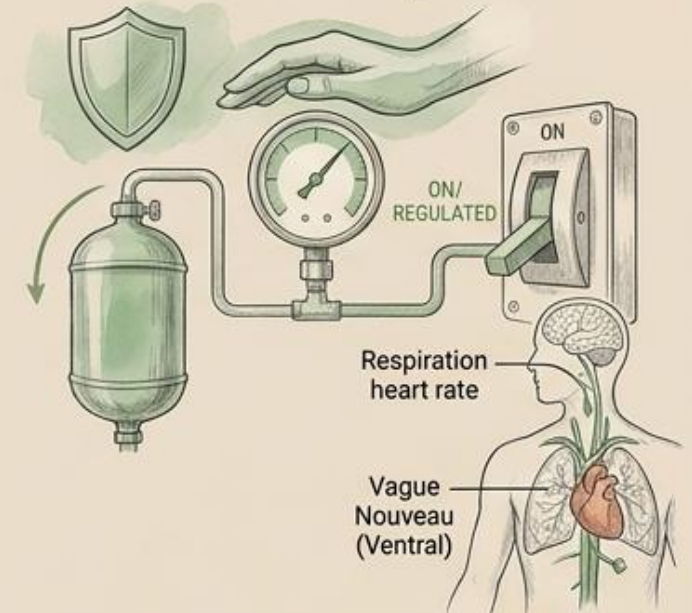
Le mécanisme de suractivation

C'est la suractivation de la branche ANCIENNE du nerf vague (réponse reptilienne de survie extrême) face à une menace perçue comme inéluctable.



La résolution régulatrice

La théorie polyvagale démontre que seule la branche NOUVELLE (ventrale) est capable de réguler à la fois l'hyperactivité sympathique et la suractivation du vague ancien.



La théorie polyvagale démontre que seule la branche NOUVELLE (ventrale) est capable de réguler à la fois l'hyperactivité sympathique et la suractivation du vague ancien.



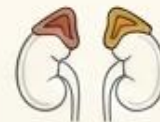
1. Système Limbique



2. Hypothalamus (CRH)



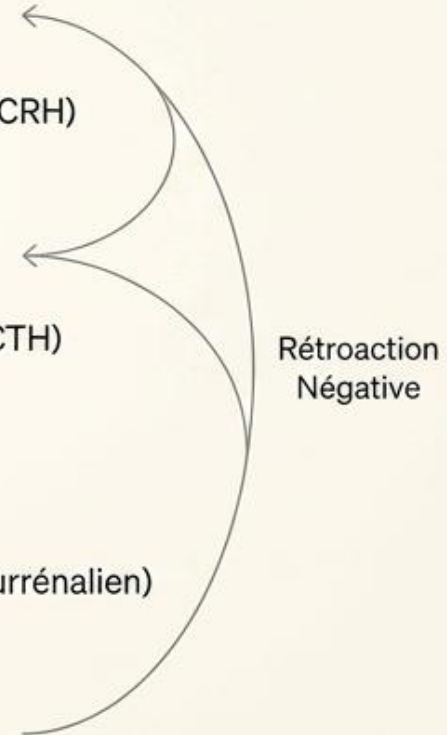
3. Hypophyse (ACTH)



4. Surrénales (Cortex surrénalien)



5. Cortisol (Circulant)



Rétroaction
Négative

CONSÉQUENCES CLINIQUES DU STRESS PROLONGÉ



Sphère Viscérale

- Troubles digestifs
- Perméabilité intestinale
- Dysbioses
- Foie congestionné
- Douleurs viscérales
- Fatigue profonde



Sphère Hormonale

- Déséquilibre Cortisol/DHEA
- Fatigue surrénalienne
- Troubles métaboliques
- Troubles du sommeil
- Déséquilibres thyroïdiens



Sphère Somatique

- Tensions musculaires
- Douleurs chroniques
- Céphalées
- Troubles posturaux
- Épuisement physique

Le Principe Thérapeutique de la ROP



Organiser l'approche thérapeutique selon la hiérarchisation évolutive (de haut en bas).

L'Objectif

Restaurer le sentiment de sécurité intérieure et améliorer la Variabilité du Rythme Cardiaque (VRC).

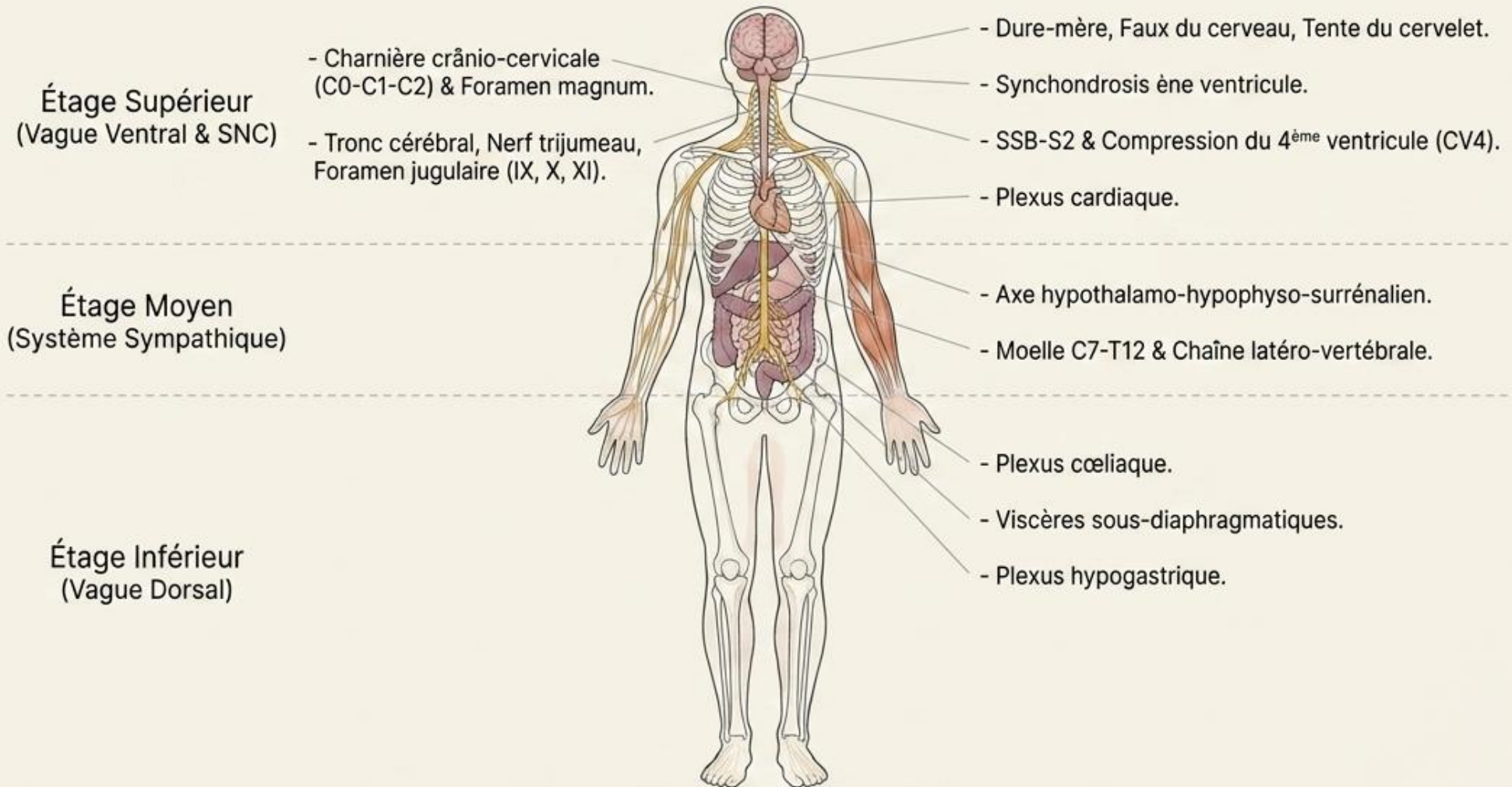
La Méthode

Optimiser d'abord la branche ventrale du nerf vague (étage crânien) pour qu'elle puisse naturellement inhiber et réguler le système Sympathique (étage thoracique) et le nerf vague ancien (étage abdominal).

L'Anamnèse

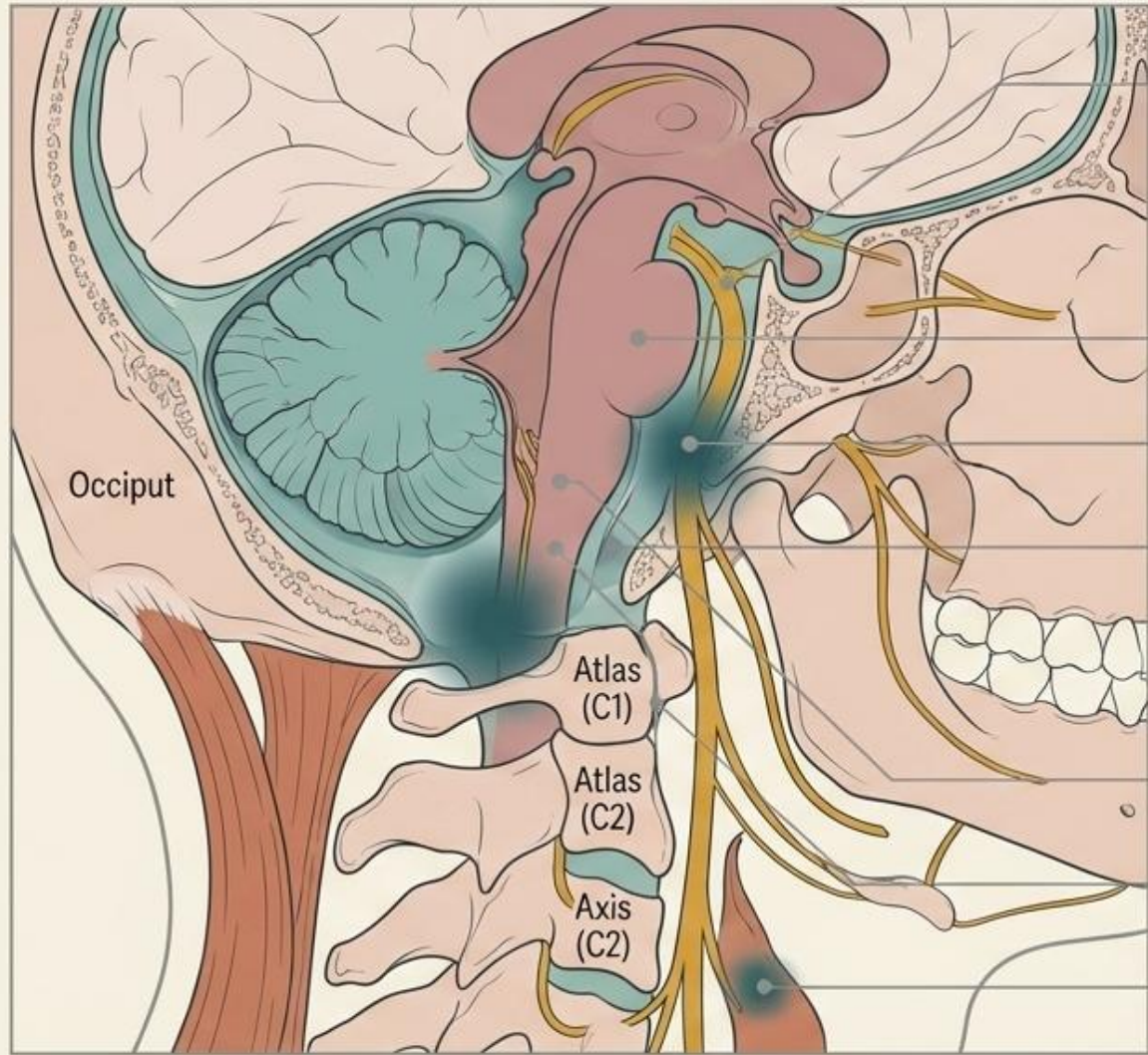
L'interrogatoire clinique doit rechercher les dysfonctions associées à cette perte de hiérarchie neuro-végétative.

La Cartographie Thérapeutique ROP



L'objectif ROP : Traiter de haut en bas pour restaurer la sécurité neurologique avant de relâcher les tensions viscérales.

Protocole ROP : L'Étage Supérieur (Le Nerf Vague Nouveau)



Charnière crânio-cervicale (Occiput-C1-C2) et foramen magnum.

Tronc cérébral, nerf trijumeau (et ses 3 branches).

Foramen jugulaire (Nerfs IX, X, XI) et nerf hypoglosse (XII).

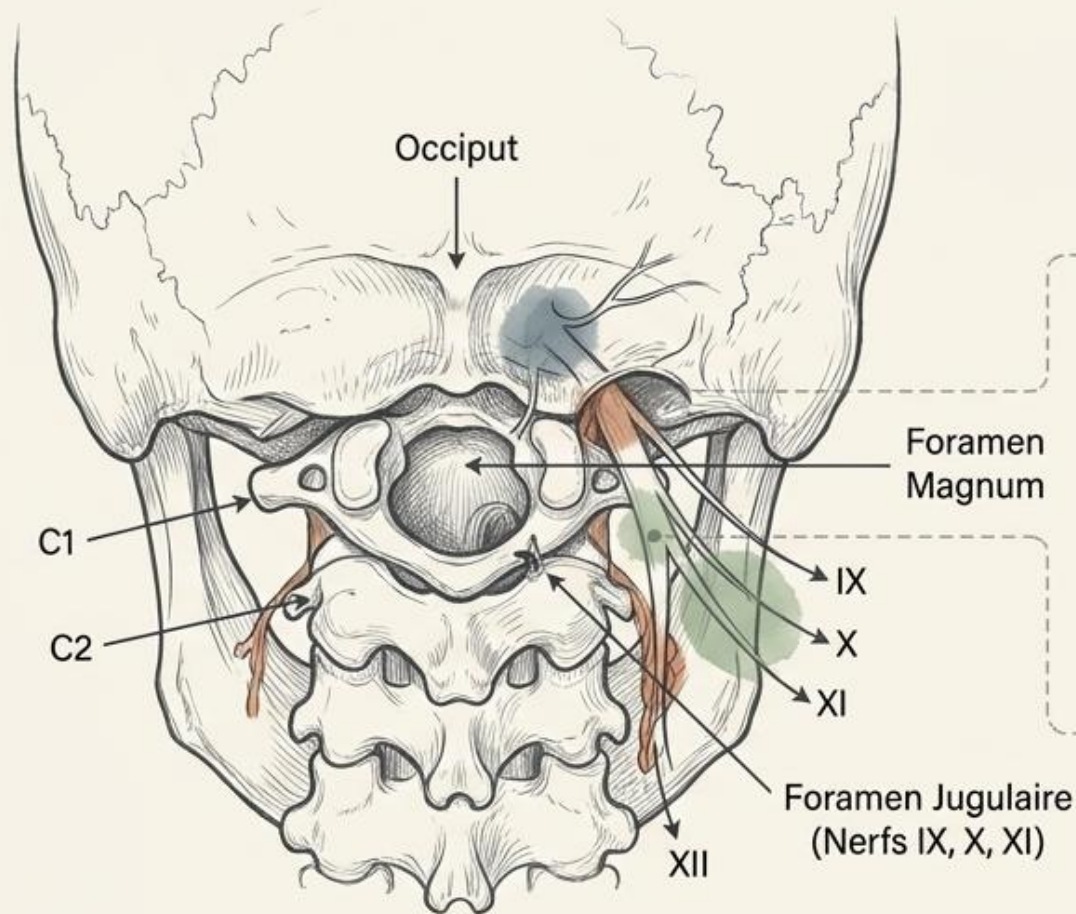
Dure-mère crânienne (faux du cerveau, tente du cervelet).

Rééquilibration Symphyse Sphéno-Basilaire (SSB) - S2.

Compression dite « du 4^{ème} ventricule ».

Plexus cardiaque (Viscères supra-diaphragmatiques).

Focus Clinique : L'Étage Supérieur



Structures Cibles :

- Charnière crânio-cervicale (Occiput-C1-C2) et Foramen magnum.
- Foramen jugulaire (passage des nerfs IX, X, XI).
- Nerf Trijumeau (V) et Hypoglosse (XII).

Techniques Clés :

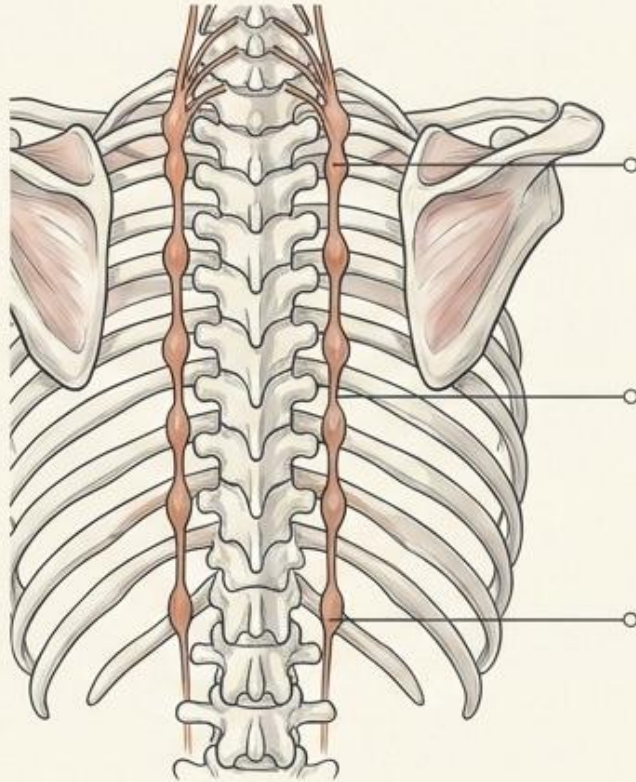
- Rééquilibration Symphyse Sphéno-Basilaire (SSB) - S2.
- Compression du 4^{ème} ventricule.

Objectif Thérapeutique : Stimuler le nerf vague nouveau pour instaurer la « neuroception de sécurité » et réguler l'ensemble de la cascade autonome.

Protocole ROP : Étages Moyen et Inférieur

Étage Moyen (Le Système Sympathique)

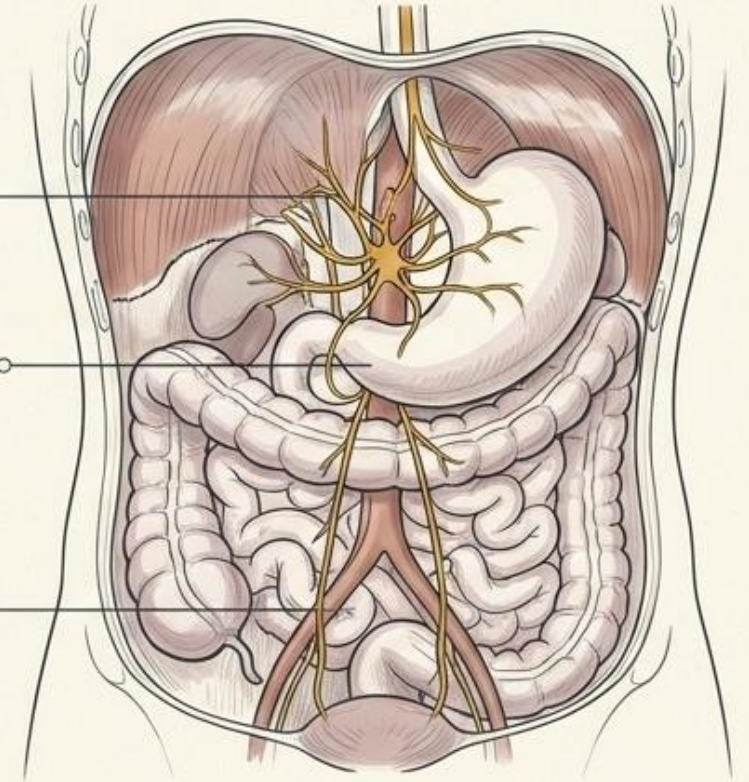
Objectif : Relâcher l'alerte et la mobilisation.



- Axe sympathico-adréno-surrénalien (SAM)
- Axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HHS)
- Chaîne ganglionnaire latéro-vertébrale.

Étage Inférieur (La Branche Ancienne du Nerf Vague)

Objectif : Restaurer la motilité viscérale profonde sans déclencher le figeage.



- Plexus coeliaque
- Viscères sous-diaphragmatiques
- Plexus hypogastrique.

Synthèse : La Carte Polyvagale ROP

1. Étage Supérieur (Sécurité) :

C0-C1-C2, SSB/S2, Foramen Jugulaire, 4ème Ventricule.

Objectif : Relance vagale ventrale.

2. Étage Moyen (Régulation) :

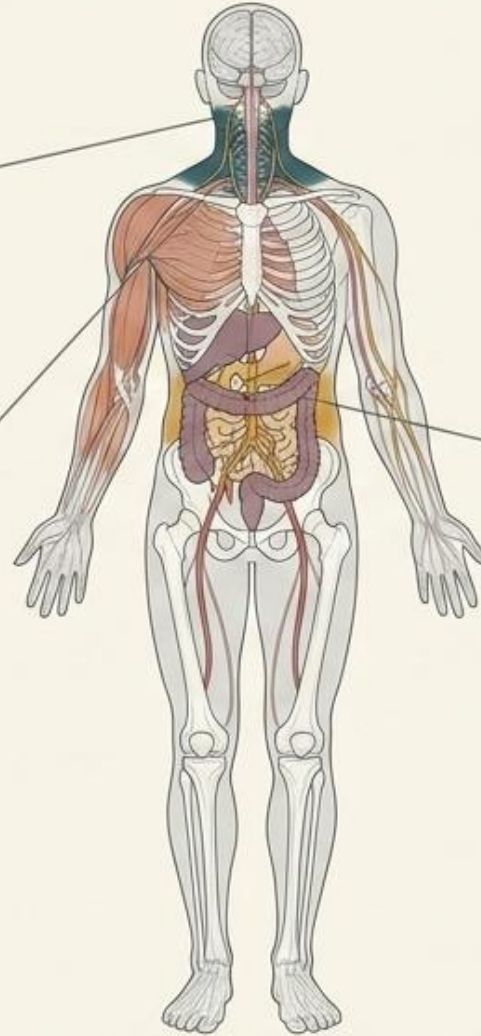
Axes SAM/HHS, Défilé thoracique.

Objectif : Diminution de l'hyper-sympathicotonie.

3. Étage Inférieur (Intégration) :

Plexus Coélique,
Plexus Hypogastrique.

Objectif : Restauration viscérale profonde.



L'objectif ultime de la ROP : restaurer la sécurité intérieure et renforcer la résilience neuro-végétative par l'intégration hiérarchique corporelle.